

40. PRATIQUE 1 LE CADRE COLIQUE

DURÉE : 03:16

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, la pratique du cadre colique est explorée à travers des points d'appui cruciaux tels que l'artère mésentérique et l'angle collique gauche. Les intervenants mettent l'accent sur la motilité intestinale et son lien avec les plans psychique et émotionnel, démontrant comment certaines tensions peuvent refléter des déséquilibres internes comme la ptose ou des dysfonctionnements viscéraux. L'importance de la normotension abdominale est soulignée, affrontant les problématiques d'hypertension et d'hypotension. Les connexions entre le côlon transverse et les certitudes personnelles, ainsi que l'impact des excès alimentaires sur le bien-être, sont également abordées, offrant aux étudiants et thérapeutes des clés pour une approche intégrative et libératrice.

PRATIQUE 1 : LE CADRE COLIQUE

Dans cette pratique, nous allons explorer les **points d'appui** essentiels dans le cadre colique.

Le **premier point d'appui** est l'**artère mésentérique**. Ensuite, le **deuxième point d'appui** se situe à l'**angle collique gauche**, qui est fixé. Le **troisième point d'appui** se trouve en profondeur. Enfin, le dernier point d'appui est lié à la dynamique de l'intestin, qui se déplace en sens inverse.

Le mouvement que nous observons est un mouvement de **motilité**. À partir de ce point, nous pouvons commencer à parcourir une **histoire**. Je suis immédiatement attiré vers l'**estomac**, la **rate** et l'angle collique gauche. Ce point d'appui est en train de rééquilibrer un **plan psychique** assez profond. Il est possible qu'il cherche à se rapprocher d'un **fulcrum** plus en avant pour retrouver des informations.

Ce point est en équilibre entre le **plan aortique** et le **plan splénique**. C'est un plan d'intégration, un inconscient qui désire remonter à la surface, pouvant s'exprimer sous forme de **rêve** ou de **cauchemar**. En plaçant le point d'appui sur le côté gauche, je cherche à obtenir une certaine **liberté**.

Le point final se situe ici. Normalement, la **tension épigastrique** doit être légèrement supérieure à la **tension hypogastrique**. Il s'agit toujours d'une recherche de **normotension abdominale** ou d'**hypotension abdominale**. Si, lors de ma palpation, je constate que la tension hypogastrique est supérieure à la tension épigastrique, cela indique un système de **ptose**.

Dans ce cas, je dois travailler sur un système de **rééquilibrage viscérospatial** ou fluide. En cas d'**hypertension**, il est nécessaire de relibérer les fluides. En revanche, pour l'**hypotension**, un relâchement est requis, ce qui implique de réintégrer le système viscérospatial pour redonner de la **dynamique** et augmenter la force.

Il est important de noter que des **excès alimentaires** peuvent encore être améliorés. En remontant, j'observe un angle qui se forme, et en redescendant, je me dirige vers ma **zone de joie**. Si les problèmes ne sont pas résolus, cela peut mener à la **zone de colère**.

Le **côlon transverse** représente mes **certitudes** dans la vie. Si ces certitudes ne sont pas résolues, elles se transforment en **doutes**. En montant, je fais face à la **zone de confiance**, où se trouvent mes **angoisses**. L'angle ici est ce que l'on appelle le **boulet du coupable**, qu'il est essentiel de dégager.

Enfin, en redescendant, j'aborde la **recherche de mon indépendance**, un processus par lequel je dois être totalement libre de mes **parents**.

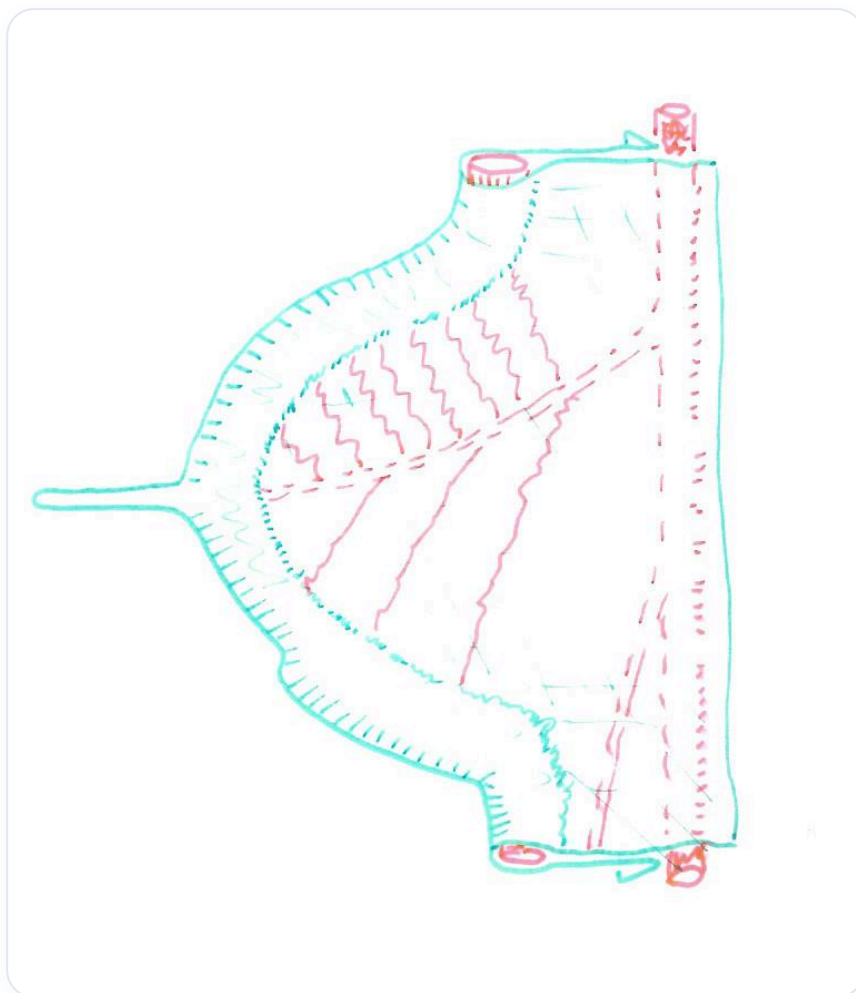


FIG. — Tube digestif embryonnaire